

7-Le Cœur_ Introduction et Origines

vosre cœur commence à battre le 21^e jour de votre vie, intra-embryonnaire. Après trois semaines, le premier système vraiment qui commence sa fonction et qui va faire ça toute sa vie, il a cette capacité de distribution de l'information. Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où le cœur bat, il y a une accélération du processus de croissance. Quel est le premier qui va recevoir vraiment la grande information du cœur ? Tout le tube neural, tout le cerveau. C'est lui qui est le moteur, c'est lui qui va aspirer. On a une relation très très importante entre le cœur et le cerveau, sur un plan fonctionnel. C'est lui qui va donner maintenant la force au cerveau. Ils se connaissent très bien, au point que même maintenant, une étude a montré que dans le système ventriculaire, dans le système profond, il y a une vibration pulsatile directe avec le cœur, qui informe le cerveau. Il y a un lien direct. Sur des plans très subtils. Et donc aussi dépendant par un autre type d'information, parce que le cœur, qu'est-ce qu'il fait ? Il distribue. Mais il distribue quoi ? Il distribue la bouffe. Ton système digestif et la relation avec la mère. Tu amènes une information trophique organisée par ton cœur, redistribuée par ton système. Donc tu es dépendant de quoi ? Finalement de ton endoderme. Tu es dépendant de ton système digestif. dans ton système de développement. Autocrine, paracrine, digestif, et puis seulement le système va apparaître. Quand on va travailler ce lien avec un enfant, très souvent je vais soigner la maman. Si la maman n'est pas libre dans sa fonction, l'enfant ne sait pas se libérer non plus, parce qu'il sera dépendant sur un plan énergétique, minimum jusqu'à 7 ans. Dans sa fonction sur le plan énergétique cellulaire, toutes les cellules de ton corps à 7 ans sont renouvelées. Donc tu as ce qu'on appelle le nouveau corps. C'est sa première naissance à lui, c'est le moment où il peut avoir la raison. C'est le moment où son sinus frontal s'ouvre et que sa théroïde devient complètement électrique parce qu'elle a réinformé son cœur. C'est pour ça qu'on peut sentir le cœur à

distance. Parce qu'il est informé par la crête neurale et qu'il a donné son information. Cette fois-ci, maintenant, je peux me défendre dans mon environnement. A 7 ans, je trouve ma première indépendance. L'ébauche du cœur apparaît dans le mésoblast planchnopleural sur un plan primitif. De nouveau, il sera dépendant, il sera dépendant de tout ce système vitellin aussi, de tout ce système qui est ici. On retrouve ici une force présomptive du cœur, regarde ma ligne primitive, dans l'épiblaste avant la gastrulation, avant le plan vasculaire, le long des cardiogéniques cells épiblastes, avec déjà tout son champ du possible. Quand je prends un sacrum ou un coccyx et que je me mets dans le système, j'ai déjà l'histoire du cœur qui se présente. Donc je dois commencer à traiter le cœur en commençant par libérer la ligne primitive, sous cette première vague qui se développe. Quand j'ai ma main, il y a une rupture déjà de la symétrie qui se fait déjà au moment de la mise en place du processus notochordal. Là ou là, tu vois, avec ici, en dessous, on a vu qu'il y avait un flux nodal qui fait qu'il y allait avoir une information où il y a des petits cils qui amènent des vésicules cérébrales, de la droite vers la gauche, via la sonétique HH, le FGH8, et finalement un changement d'acide rétinoïde, c'est-à-dire un changement sur le plan calcique qui donne une intégration différente dans l'information génétique, qui fait qu'au bout du compte, j'ai une rupture de la symétrie de la droite vers la gauche, où déjà il y a une information importante qui est donnée à ce niveau-ci. Cette rupture de la symétrie va être un des facteurs qui positionnera dans le futur mon cœur vers la gauche, avec des molécules morphogénétiques, avec finalement une augmentation du taux calcique sur toute une lame latérale qui se fera ici, et donc toute l'information de l'intégration génétique qui sera différente. Déjà, cette asymétrie se fait entre, on pourrait dire, la base du crâne et le sacrum, et avec cette ligne primitive, si tu veux. La déviation est ici, c'est un flux qui vient de la droite vers la gauche. Ça se retrouve sur un

autre niveau encore, par les cellules nourricières folliculaires qui libèrent des enzymes qui créent déjà une polarité au sein de l'ovocyte, dans le cytosquelette, qui fait que j'ai déjà une première polarisation qui se fait sur un plan crânio-caudal et dorsoventral, sauf qu'il n'est pas informé de son environnement extérieur. et on constate que le lieu de pénétration du spermatozoïde va donner une réinformation dans l'axe longitudinal de l'embryon où j'ai cette force présomptive qui sera créée. Cette intégration est déjà une information de l'extérieur par la force du spermatozoïde qui restructure la force du cytosquelette dans un plan presque électromagnétique. Et certains décrivent que, en fait, ça se retrouve sur un embryon dans sa partie apicale. Ça veut dire que j'attrape un champ présomptif d'information. Et c'est comme ça que dans ce champ présomptif, je vais retrouver la phase cardiogénétique future. Le spermatozoïde, quelque part ici, c'est déjà d'une certaine façon la force cardiaque, la pulse qui se prépare là. Mais il n'y a pas encore de forme ici. C'est pour ça que c'est une préforme. Et puis on va voir très vite que tu vas avoir finalement toute une organisation de ton embryon avec la fameuse ola qui va se développer, avec finalement un point d'appui ici et un point d'appui ici, avec ma ligne primitive ici, et avec la réintégration de ce système. L'importance, déjà, de ce point-ci et de ce point-ci. Le deuxième point, ce sera le moment où j'ai la vague, c'est-à-dire que j'ai le passage de la mise en place de ma troisième chambre embryonnaire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le cellome ou le léciteux cellexterne, qui va réorganiser l'embryon et qui va faire que je vais avoir une structure en forme de S. Mais à ce moment-là, c'est là où je vais avoir l'intégration par rapport au point d'attache, et c'est ça qui donne ma ligne primitive. Dans un embryon, le cœur, il est là, ça fait ça. Le cœur, il a trouvé sa place, il a intégré le péricarde, il a intégré le septum transversum, avec ces piliers diaphragmatiques qui seront là, qui vont devenir un point d'appui pour mon système

cardiaque. Ça veut dire que traiter un cœur, c'est libérer le diaphragme, puisque c'est son orientation qui fait ça. Donc le diaphragme devient vraiment notre outil thérapeutique, puisque les cellules péricardiques, ce sont les mêmes cellules qui vont se retrouver sur le plan du septum transversum, c'est-à-dire du diaphragme. Où est-ce qu'elles prennent leur origine ? J'ai mon cœur, et là j'ai des petites cellules, qui sont les cellules mésenchymateuses, qui formeront mon diaphragme. L'ectoderme, il grandit à fond, et ça se balance, et ça va former tout ce système-là. Le spermatozoïde, il arrive, et toi tu as la clé ici, on peut se rencontrer. La pilule a tué le concept. La pilule a tué la possibilité de conceptualiser. On a coupé le système hormonal pendant des années. Et puis de plus en plus, les femmes, maintenant, elles ont des difficultés d'avoir les enfants. Il y a un niveau médical qui est arrivé, et on a dit, maintenant, on peut vous aider. On fait ce qu'on appelle des IMSI, qu'on prend une aiguille, et on pique, et on traverse la membrane. Et si on est à un bon endroit par rapport à la polarité, Sauf qu'on n'a pas la première reconnaissance, qui est une reconnaissance membrane, qui est une reconnaissance coranère, qui est une reconnaissance tissulaire, qui est une reconnaissance moléculaire. Probablement, ils vont avoir de plus en plus de problèmes de fertilité. Donc ils ne vont plus savoir se reproduire ni se reconnaître. On a enlevé la première reconnaissance. Ces enfants qui viennent en consultation, on en a, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître sur quel niveau du corps ? Leur cœur. Il faut les contacter par le regard dans leur cœur. Si tu le fais, tu vas voir que l'enfant, il sait ça. C'est la seule chose que tu peux donner. Je peux te reconnaître, te refaire naître. Sinon, ces gens, ils vont être en recherche toute une vie, parfois, comme ça. Ça se passe déjà dans ton système vasculaire primitif. Cinquième jour, enfin, cinquième, sixième. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le zygote, il doit avoir une puissance métabolique dans un pôle spécifique. C'est-à-dire

que le trophoblaste cellulaire doit se transformer en syncytiotrophoblaste. Ça veut dire que ce syncytiotrophoblaste a une activité lithique de pouvoir pénétrer la muqueuse. Si l'embryon n'a pas cette puissance, il ne sait pas entrer dans sa muqueuse. Deuxième chose, il faut que la mère soit accueillante. Mais ce n'est pas elle qui fait le travail pour l'embryon. Est-ce qu'il a reçu cette puissance ? Je vous rappelle que sa puissance métabolique est déterminée d'abord par une phase de dédifférenciation cellulaire. C'est-à-dire que pendant les trois, quatre premiers jours, le zygote ne grandit pas. Par contre, il augmente sa division cellulaire, au clivage, à grande vitesse, j'ai une augmentation globale de ma membrane, et j'ai une petite perte d'eau à l'extérieur. C'est là qu'il va créer cette première cavité qu'on appelle germe du ciel, le blast cell, qui est une connexion spécifique de ton ciel extérieur. Et puis par contre, au niveau cellulaire, je vais avoir une augmentation de ma membrane. Donc si j'ai une augmentation de ma membrane, j'ai une augmentation de quoi ? D'échanges. Puisque les membranes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des espaces d'échanges, toujours polarisés. Si j'ai une cellule, j'ai un noyau, et je vois que mon noyau est concentré. Il est toujours ici. Donc c'est ici que j'ai ma plus grande force d'échanges. Au lieu d'en avoir 50, je vais en avoir 3000. Les cellules dans cette phase de division deviennent 200 fois plus petites que les deux blastocelles originelles. Relativement, j'ai une augmentation de ma membrane. Si je prends ma membrane par rapport à mes deux premiers blastomères, on va dire que ça fait 100 mètres. Si je prends toutes ces petites membranes, j'augmente énormément. J'augmente ma puissance métabolique. Si j'ai une puissance métabolique suffisante, j'ai une force suffisante pour entrer. Et cette puissance métabolique, je vais toujours en avoir besoin, toute ma vie. C'est un peu la pile que tu vas recevoir. Et tu dois faire confiance à ça. Et ça se régénère jusqu'à un certain temps par ton sommeil, par ton alimentation, par ta

respiration, par tes justes pensées, etc. Tu les dégénères si tu ne respectes pas ça et si tu es intoxiqué. Tu perds tes substrats fondamentaux de cette puissance qui sont portés là. Donc tu as besoin de ça. Donc le cœur, déjà, prend son origine pratiquement dans le contact du spermatozoïde, dans cette rencontre, de façon symbolique, on peut dire. Après, on la retrouve au niveau de ma ligne primitive. Puis, une information déjà des champs cardiaques qui se font ici en rapport avec la place d'une œdène saine, c'est dans la vague de croissance du développement des champs cardiaques. Et puis on va voir une chose qui est très importante, c'est tout ce mouvement développemental.